

Şizofreni

Şizofreni, kişinin gerçekliği algılama ve değerlendirme biçimini önemli ölçüde etkileyebilen, beynin işleyişiyle ilişkili ciddi bir ruhsal bozukluktur. Hastalık yalnızca düşünceleri değil; kişinin duygularını, davranışlarını, dikkatini, hafızasını, problem çözme becerilerini ve diğer insanlarla ilişkilerini de etkileyebilir. Genellikle geç ergenlik, yirmili yaşlarda ve erken yetişkinlik döneminde belirginleşir. Ancak şizofreni tek bir biçimde ilerlemez: bazı kişilerde belirtiler dönem dönem artıp azalırken, bazı kişilerde zaman içerisinde daha kalıcı sorunlar görülebilir.

Şizofreninin en dikkat çekici özelliklerinden biri, kişinin gerçeklikle olan bağının bozulabilmesidir. Örneğin kişi, gerçekte olmayan sesleri duyabilir veya olmayan şeyleri görebilir, hissedebilir ya da koklayabilir. Buna halüsinasyon denir. Bir başka belirti olan sanrı da kişi, aksini gösteren kanıtlar olsa bile belirli bir düşüncenin doğru olduğuna kesin biçimde inanabilir. Bunun yanında düşünceler dağınık hale gelebilir ve konuşmaların anlaşılması zorlaşabilir. Davranışlarda belirgin düzensizlik veya kişinin hareketlerinde aşırı artış ya da yavaşlama da görülebilir.

Ancak şizofreniyi yalnızca bu belirtilerden ibaret düşünmek eksik olur. Hastalığın daha az dikkat çeken fakat kişinin günlük yaşamını ciddi şekilde etkileyebilen negatif ve bilişsel belirtileri de vardır. Kişi konuşmakta, duygularını göstermek veya zevk aldığı şeylere ilgi duymakta zorlanabilir ve insanlardan uzaklaşabilir. Bunun yanında dikkat, çalışma belleği, öğrenme, problem çözme, bilgiyi işleme ve sosyal durumları değerlendirme gibi bilişsel becerilerde güçlükler ortaya çıkabilir. Bu sorunlar eğitim, iş hayatı ve sosyal ilişkiler gibi günlük yaşam alanlarında önemli sonuçlara yol açabilir.

Araştırmalar hastalığın tek bir nedeninin olmadığını göstermektedir. Genetik özellikler önemli bir rol oynarken, çevresel etkenlerin de hastalık riskine katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Beyin gelişimiyle ilgili araştırmalar, şizofrenide beynin gelişme ve olgunlaşma sürecinin normalden farklı olabildiğini göstermektedir. Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemindeki beyin gelişimi sırasında sinir hücreleri arasındaki bağlantılarda meydana gelen değişikliklerin hastalıkla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Genetik ve çevresel etkenlerin bu süreçlerle birlikte rol oynadığı görülmektedir.

Beyindeki iletişimi sağlayan bazı kimyasal sistemler de şizofrenide önemlidir. Özellikle dopamin ve glutamat sistemlerindeki bozukluklar üzerinde durulmaktadır. Dopamindeki bazı dengesizlikler özellikle sanrı ve halüsinasyon gibi psikotik belirtilerle ilişkilendirilirken, glutamat sistemindeki bozuklukların bilişsel sorunlarda önemli bir rol oynayabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle şizofreni, yalnızca

düşüncelerle ilgili bir sorun olarak değil, beynin farklı işlevlerinin birlikte etkilendiği karmaşık bir hastalık olarak ele alınmaktadır.

Şizofreninin tedavisinde antipsikotik ilaçlar önemli bir yere sahiptir. Bu ilaçlar özellikle psikotik belirtilerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Bunun yanında psikoeğitim, aile desteği, bilişsel-davranışçı terapi ve psikososyal rehabilitasyon gibi yaklaşımlar da tedavinin önemli parçalarıdır. Özellikle kişinin günlük yaşam becerilerini geliştirmesine, sosyal yaşamını sürdürmesine ve mümkün olduğunca bağımsız bir yaşam kurmasına destek olmak önemlidir. Bununla birlikte, tedaviye rağmen bilişsel belirtiler tamamen ortadan kalkmayabilir ve bu alan için yeni tedavi yöntemleri üzerinde araştırmalar devam etmektedir.

Şizofreni ciddi bir hastalık olsa da her kişi için aynı şekilde ilerlemez. Kaynaklara göre şizofreni yaşayan kişilerin en az üçte birinde belirtilerde tam iyileşme görülebilmektedir. Bu nedenle hastalığı yalnızca ağır belirtiler üzerinden değerlendirmek doğru değildir. Erken ve düzenli tedavi, sosyal destek ve kişinin tedavi sürecine aktif olarak katılması önem taşır.

Son olarak, şizofreni yalnızca hastalığı yaşayan kişiyi değil, ailesini ve sosyal çevresini de etkileyebilir. Hastalığa yönelik damgalama ve ayrımcılık ise kişinin toplumsal yaşama katılımını daha da

zorlaştırabilir. Bu nedenle şizofreniyi anlamının önemli bir parçası da hastalığı yaşayan kişiyi yalnızca belirtileriyle değil, tedaviye, desteğe ve yaşamını sürdürebilmesine ihtiyaç duyan bir insan olarak görmekten geçer.

Kaynaklar:

- 1) World Health Organization. (2025, October 6). *Schizophrenia*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/schizophrenia>
- 2) Javitt DC. Cognitive Impairment Associated with Schizophrenia: From Pathophysiology to Treatment. *Annu Rev Pharmacol Toxicol*. 2023 Jan 20;63:119-141. doi: 10.1146/annurev-pharmtox-051921-093250. Epub 2022 Sep 23. PMID: 36151052.
- 3) Cummings MA, Arias AW, Stahl SM. What is the neurobiology of schizophrenia? *CNS Spectr*. 2024 Oct 30;30(1):e13. doi: 10.1017/S1092852924000518. PMID: 39473188; PMCID: PMC13064734.

Yayın Tarihi: Temmuz 2026

Sorumlu Yazar: Ali Bocakkıtaç/ Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi